Diodo en **endodoncia**

Este resumen recoge las ideas principales de la plática para que las tengas a la mano. Es un recordatorio, no un curso: no incluye protocolos ni parámetros clínicos.

01 Tres longitudes de onda, tres trabajos

Un diodo de varias longitudes de onda no es un solo láser: el azul, el rojo y el infrarrojo interactúan con componentes distintos del tejido. Elegir la longitud de onda adecuada es el primer paso para un buen resultado.

02 La seguridad sigue primero

Aunque ya se use el láser todos los días, los lentes específicos para cada longitud de onda, la activación fuera de boca y el cuidado con los reflejos no son opcionales.

03 Los errores más frecuentes

La mayoría de los problemas con el diodo no son del equipo: vienen de ignorar la densidad de energía, confundir frecuencia con potencia, olvidar el ciclo de trabajo, no considerar el diámetro de la fibra, mover la fibra a una velocidad inadecuada o confiar a ciegas en los programas del equipo. El láser no se equivoca: los parámetros sí.

04 Desinfectar el conducto con diodo

El diodo trabaja en el conducto seco, después de la instrumentación y la irrigación, nunca en lugar de ellas. La luz infrarroja lleva calor controlado a la dentina profunda; la luz azul es absorbida por moléculas propias de las bacterias. Combinadas, se complementan.

05 Tejidos blandos

Frenectomías y lesiones como el herpes también se benefician del diodo: menos sangrado, menos inflamación y un postoperatorio más cómodo. La clave es la misma que en el conducto: la técnica y la energía adecuadas para cada tejido.

06 ¿Y el erbio?

Diodo y erbio no compiten. El erbio actúa a través del agua: activa el irrigante y remueve el barrillo dentinario. El diodo penetra en la dentina. Cada uno tiene su lugar.

07 Fotobiomodulación: la dosis es el fármaco

La respuesta de la célula a la luz es bifásica: poca luz no hace efecto y demasiada puede inhibirlo. Por eso lo que importa es la dosis, no la potencia del equipo, y por eso hay que medir en lugar de adivinar.

08 El tratamiento empieza 72 horas antes

Preparar la célula con luz antes del procedimiento, aplicar fotobiomodulación al terminar y continuar en casa son tres fases de un mismo plan para que el paciente se recupere mejor.

Para llevarte

- Los resultados dependen de los parámetros, no del equipo.
- El diodo complementa la limpieza del conducto; nunca la sustituye.
- En fotobiomodulación, la dosis es el fármaco.
- El tratamiento empieza 72 horas antes, y todas tus dudas están en LaserRx.

¿Quieres profundizar? Las explicaciones completas, con animaciones y casos, están en **LaserRx Academy**. Y todas tus dudas clínicas, en LaserRx.

laserapp.ai

La bibliografía completa está en la misma página donde descargaste este resumen.

Dr. Isaac Kably M., DDS, MSc — Endo & Laser

Material educativo. No sustituye la formación clínica ni el juicio profesional.